Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Comarca de Mendes

Vara Única

Rua Alberto Torres, 114, Centro, MENDES - RJ - CEP: 26700-000

_____

Processo: 0800295-63.2024.8.19.0032

Classe: [Fornecimento de medicamentos]

AUTOR: AUTOR: EDIR PEREIRA COSTA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-DPGE
INTERESSADO: DP ÚNICA DE MENDES (782)

RÉU: RÉU: MUNICIPIO DE MENDES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SENTENÇA

Trata-se de ação em que figura como parte autora **EDIR PEREIRA COSTA** e, como partes rés, o **MUNICÍPIO DE MENDES** e o **ESTADO DO RIO DE JANEIRO**.

ID 111402201: petição inicial. Afirma a parte autora que "é cidadão e portador de Diabetes Mellitus Insulino Dependente – Com Complicações Oftalmológicas (CID E10.3)" e que necessita dos medicamentos/insumos indicados na petição inicial para a sua sobrevida.

ID 111920534: decisão concessiva da gratuidade de justiça e da tutela de urgência.

ID 118869002: contestação do Estado do Rio de Janeiro. Sustenta a manifesta incompetência da justiça estadual para processar e julgar demanda que veicula pretensão de pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído em nenhuma lista obrigatória de dispensação do SUS. Afirma que deve figurar a União no polo passivo. Afirma que o Estado possui uma política pública para atendimento de pacientes com diabetes, que abrange todos os medicamentos e insumos necessários. Defende a necessidade de produção de prova pela parte autora da ineficácia dos substitutos terapêuticos e a a impossibilidade da escolha de marcas pela parte autora. Alega ilegalidade, desnecessidade, inadequação e desproporcionalidade da multa cominatória. Sustenta a relevância de trâmites administrativos. Aduz a necessidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa.

ID 128311912: contestação do Município de Mendes. Indica conta bancária para a garantia do cumprimento das decisões. Sustenta a competência da Justiça Federal e a necessidade de inclusão da União no polo passivo. Impugna o valor da causa. Aduz a existência de medicamentos fornecidos pelo SUS e a ausência de documentação válida a subsidiar o pleito

autoral. Afirma que não foram cumpridos os requisitos para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS. Rechaça a possibilidade de condenação do Município de Mendes em custas judiciais.

ID 137715830: réplica. Reitera os termos da inicial e diz que não tem outras provas a produzir.

ID 138090060: decisão saneadora que afastou a preliminar de incompetência do Juízo.

ID 138090062: nota técnica do e-NatJus (parcialmente favorável).

ID 139108848: manifestação da Defensoria Pública.

ID 143400783: manifestação do Município de Mendes requerendo a produção de prova documental suplementar, consubstanciada na intimação da autora para apresentar novo laudo, prescrito por profissional do SUS, indicando a persistência do tratamento e utilização dos fármacos requeridos, bem como a apresentação de comprovante de cadastramento no Polo de Dispensações de Medicamentos do Estado do Rio de Janeiro e a intimação pessoal do médico que assina o laudo médico apresentado nos autos para testar a imprestabilidade dos fármacos padronizados e gratuitamente disponibilizados pelo SUS ante a Nota Técnica apresentada.

ID 169394521: determinada a vinda de novo laudo médico, a parte autora cumpriu o determinado no index 169394521 e requereu a exclusão dos medicamentos **INSULINA NPH 10ML e INSULINA REGULAR 10ML.**

ID 184646775: manifestação do Município de Mendes.

ID 186486416: manifestação do Estado do Rio de Janeiro.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.

Segundo determina a regra contida no art. 355, inciso I, do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O juízo de necessidade da prova é exercido na forma prevista no art. 370 do CPC, que determina caber ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Esse juízo de necessidade é orientado, ainda, pela regra contida no art. 370, parágrafo único, do CPC: "O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

Um aspecto que não pode ser ignorado na valoração da necessidade da prova é o princípio da razoável duração do processo, pois "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", conforme determina o art. 4º do CPC.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de intimação pessoal do médico que subscreve o laudo médico apresentado nos autos, tendo em vista que o laudo mais recente contém informação acerca da imprestabilidade dos medicamentos fornecidos pelo SUS, não sendo necessária nova intimação para atestar o que já se encontra nos autos.

Portanto, atento ao que consta dos autos, **PASSO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO** (art. 355, inciso I, do CPC).

Existem preliminares e questões pendentes, as quais passo a resolver.

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

O valor da causa não é atribuído de maneira aleatória ou subjetiva. A atenta leitura do art. 292 do Código de Processo Civil demonstra que a sua inteligência é no sentido de que o valor da causa deve refletir, tanto quanto possível, o conteúdo econômico em litígio. Esse é o ponto em comum das hipóteses indicadas nos seus incisos e parágrafos.

A questão se torna controvertida neste feito porque é necessário compreender qual é o conteúdo econômico da condenação que se pretende impor aos réus – i.e. fornecer medicamentos/insumos. Isso porque o tratamento pleiteado pela parte autora pode terminar em alguns meses, mas também pode se prolongar de maneira perene, pois alguns medicamentos são indispensáveis para a manutenção da qualidade de vida e da saúde da pessoa que dele precisa.

Por isso, faz-se necessário indagar e compreender qual é a extensão da qualidade econômica da causa quando o que se pretende é o fornecimento de medicamentos por um período, ao menos em tese, indefinido. Nesse sentido, entendo que a regra que melhor se coaduna é a prevista no art. 292, inciso III, do Código de Processo Civil, pois ela trata exatamente de prestações continuadas e sucessivas, as quais, à semelhança dos medicamentos, se revelam necessárias à sobrevida da parte destinatária.

Por isso, **deve** ser atribuído como valor da causa o montante correspondente ao custo dos medicamentos/insumos necessários para **12 (doze) meses** de tratamento, conforme o seu valor ao tempo do ajuizamento da ação, segundo os orçamentos que constam dos autos.

Nesse sentido, analisando cuidadosamente a inicial e os orçamentos que a acompanharam, entendo que o valor indicado pela parte autora se encontra correto, uma vez que foi levado em consideração o menor valor de cada medicamento, ainda que em estabelecimentos diferentes.

Portanto, **REJEITO** a impugnação.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DE MEDICAMENTO/ INSUMO

No ID 169394521, a parte autora traz aos autos a informação de que não necessita mais fazer uso dos medicamentos INSULINA NPH 10ML; II - INSULINA REGULAR 10ML, motivo pelo qual requereu a exclusão de ambos do rol de medicamentos deferidos pelo Juízo.

Considerando a desnecessidade do recebimento dos medicamentos acima mencionados, **DEFIRO** sua exclusão.

Não há outras questões preliminares, tampouco questões pendentes a serem decididas. Não constato nulidades a serem sanadas. Passo ao Julgamento do Mérito.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia em determinar **se a autora tem direito de receber dos entes públicos os medicamentos requeridos.**

Antes de prosseguir, é fundamental balizar a relação jurídica existente entre as partes.

A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental, manifestando o legislador Constituinte constante preocupação em garantir a todos meios de obter uma existência digna, consoante os ditames de justiça social, o que se extrai dos artigos art. 1º, item III, 6º, 196 e 197:

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos [...] III - a dignidade da pessoa humana [...]”.

***

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”.

Os preceitos constitucionais acima transcritos demonstram que a extensão da tutela constitucional tendente a assegurar a todo o cidadão, independentemente de sua condição econômica e social, o direito à saúde, impondo para tanto, ao Estado, o dever constitucional de garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica e farmacológica.

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível e deve ser assegurado à generalidade dos cidadãos. Logo, cabe ao Estado a partir dos recursos que se fizerem necessários ao tratamento da moléstia de que padece a parte, garantir o direito à saúde, permitindo aliviar o sofrimento e a dor de enfermidade reversível ou irreversível.

DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO. MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDOS PELO SUS.

A presente situação exige delimitar o quanto a jurisprudência sedimentou a respeito do fornecimento de medicamentos, pelo Poder Público, quando estes não são fornecidos pelo SUS.

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Declaração no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo), sedimentou a tese para solução desses casos. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: **a)** Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; **b)** incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; **c)** existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Além disso, o STJ decidiu alterar a data de início da produção dos efeitos desta decisão. Foram modulados os efeitos do repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. Explicando melhor: **a)** Os três requisitos cumulativos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018; **b)** Quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior a 4/5/2018, é exigível apenas um requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

Essa orientação **não** viola o princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CRFB), pois uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição da República, como o direito à *saúde* (*Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação*).

A propósito do tema, o STF, ao interpretar os arts. 5º, caput, e 196 da CRFB/1988, consagrou o direito à saúde como consequência indissociável do direito à vida, assegurado a todas as pessoas (STF. 2ª Turma. ARE 685.230 AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/03/2013). Para alcançar esse objetivo, a CRFB/1988 determinou a criação de um sistema único de saúde (SUS), que tenha como uma de suas diretrizes o "atendimento integral" da população (art. 198, II, da CF/88).

A fim de dar concretude ao SUS, foi editada a Lei nº 8.080/90, que prevê que o Poder Público deverá fornecer assistência integral, inclusive farmacêutica:

"Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. (...)

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). (...)

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: (...) d) **de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica**". (destaquei)

Em 2011, foi editada a Lei n. 12.401/2011, que incluiu diversos dispositivos na Lei nº 8.080/1990 para tratar da assistência terapêutica e prever o fornecimento de medicamentos. Cabe observar o quanto dispõe o art. 19-M, um dos dispositivos acrescentados:

"Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6º consiste em: I - **dispensação de medicamentos** e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, **em conformidade com o disposto no art. 19-P**; (...)"

A regra contida no art. 19-P determina que a dispensação (fornecimento) de medicamentos será feita com base no protocolo clínico ou de diretriz terapêutica e, na falta disso, com base nas relações de medicamentos do SUS:

"Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada:

I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite;

II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite;

III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde."

É nesse âmbito que se insere a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de o medicamento não integrar a lista básica do SUS não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais (STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp 405.126/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 26/10/2016).

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde. Com efeito, segundo já decidiu o STJ: "*Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.*" (STJ. 2ª Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014).

Inclusive, essa leitura reverbera também no Supremo Tribunal Federal: "(...) É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. (...)" (STF. 1ª Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016).

Neste caso, aliás, sequer se trata de verdadeira implementação de política pública, pois este Juízo nada está decidindo de maneira abrangente, mas apenas em relação ao caso concreto.

Diante disso, importa retornar aos requisitos estipulados pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Declaração no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo): **a)** Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; **b)** incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; **c)** existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

É necessário detalhar o primeiro requisito.

Quanto a ele ("**a)** Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS"), releva observar o Enunciado n. 15, aprovado na I Jornada de Direito da Saúde, organizada pelo **Conselho Nacional de Justiça**: "E*nunciado 15: As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica*".

Também releva observar que, segundo já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, esse laudo médico **NÃO** precisa ser assinado por médico vinculado ao SUS: "(...) Ressalte-se, ainda, que não há no ordenamento, jurídico brasileiro qualquer exigência que condicione o fornecimento de medicamento à prescrição exclusivamente por médico da rede pública. (...)" STJ. AgInt no REsp 1.309.793/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 07/04/2017.

No presente caso, a parte autora pretende receber o(s) seguinte(s) medicamento(s): Jardiance 10mg e Glifage XR 500mg.

Considerando que o medicamento Glifage XR 500mg se encontra previsto para fornecimento por meio do SUS, conforme a listagem RENAME atualmente vigente, passo a apreciar os requisitos em relação ao medicamento Jardiance 10mg:

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS: está comprovado nos autos, cf. fl(s)./IDs 111402204 e 169394523, que os medicamentos fornecidos pelo SUS não são adequados ao caso concreto;

b) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito: a hipossuficiência econômico-financeira da parte autora ficou cabalmente demonstrada nos autos, através dos documentos acostados no ID 111402202;

c) Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência: o medicamento tem registro na Anvisa e os usos pretendidos são compatíveis com os usos autorizados.

DISPOSITIVO.

Portanto, RATIFICO a tutela de urgência, **JULGO PROCEDENTE** o pedido e **DETERMINO** que os réus, solidariamente, forneçam à parte autora, gratuitamente, os medicamentos descritos às fls./ID 169394523, nos exatos termos prescritos, em prestações mensais e contínuas pelo tempo que se fizer necessário.

DEIXO de condenar o **Município de Mendes** ao pagamento das custas, tendo em vista o quanto disposto nos arts. 17, inciso IX, e art. 10, inciso X, da Lei Estadual n. 3.350/1999 ("Art. 10 - Consideram-se custas ou despesas judiciais, a serem contadas para efeitos processuais, o valor monetário correspondente: [...] X - a taxa judiciária [...] Art. 17 – São isentos do pagamento de custas judiciais: [...] IX – a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, os Territórios Federais e as respectivas autarquias e fundações públicas de direito público, exceto quanto aos valores devidos a peritos, arbitradores e intérpretes), bem como a disposição contida no art. 110 da Lei Municipal n. 856/2001. Todavia, considerando a redação do verbete n. 145 da Súmula do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ("*Se for o município autor estará isento da taxa judiciária desde que se comprove que concedeu a isenção de que trata o parágrafo único do artigo 115 do CTE, mas deverá pagá-la se for o réu e tiver sido condenado nos ônus sucumbenciais*"), **CONDENO-O** ao pagamento da taxa judiciária, pois neste feito figura como réu, não como parte autora. **CONDENO-O**, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do **CEJUR/DPGE**, na forma e montante descrita abaixo.

Quanto ao **Estado do Rio de Janeiro**, **DEIXO** de condená-lo em custas em virtude da isenção prevista na Lei Estadual n. 3.350/1999. Semelhantemente, **DEIXO** de condená-lo ao pagamento da taxa judiciária, por se tratar de um tributo estadual recolhido para o Fundo Especial do TJRJ, instituído pela Lei Estadual n° 2.525 de 22/01/1996, sendo parte integrante da própria estrutura administrativa do Estado do Rio de Janeiro, pois, do contrário, acarretaria o fenômeno da

confusão. **CONDENO-O**, porém, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do **CEJUR/DPGE**, na forma descrita abaixo, tendo em vista que, além do cancelamento, houve a superação da *ratio* subjacente ao verbete n. 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (cf. Tema 1002-STF: Teses fixadas: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". STF. Plenário. RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/06/2023 – Repercussão Geral – Tema 1.002 – Info 1100). Ademais, houve o **CANCELAMENTO** do **verbete n. 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça** (STJ. Corte Especial. Súmula 421 cancelada em 17/4/2024 (Info 808).

Quanto aos **HONORÁRIOS** a serem pagos em favor do em favor do **CEJUR/DPGE**, deve-se observar que a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça, julgando pelo sistema dos recursos repetitivos os Recursos Especiais nº 1.850.512/SP, nº 1.877.883/SP, nº 1.906.618/SP e nº 1.906.623/SP, referentes ao Tema nº 1076/STJ, firmou, em sessão realizada em 16/03/2022, a seguinte tese: **i)** A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: **(a)** da condenação; ou **(b)** do proveito econômico obtido; ou **(c)** do valor atualizado da causa. **ii)** Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.". Portanto, os honorários deverão corresponder a **10% (dez por cento)** do valor atualizado da causa, cf. art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Os réus deverão pagar, em partes iguais, o montante referente aos honorários – i.e. cada réu sucumbente deverá pagar metade (50%) dos honorários.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Fica a parte autora **ADVERTIDA** de que **DEVERÁ**, independentemente de futuras intimações, **COMPROVAR** a necessidade da medicação/insumo por meio de apresentação de receita médica a cada **6 (seis) meses**, além de laudo médico atualizado a cada **6 (seis) meses**, demonstrando o estágio de tratamento e a persistência da necessidade de uso da medicação/insumo, sob pena de cessar a obrigação dos réus.

ADVIRTO os réus de que a cessação indicada no parágrafo anterior, se ocorrer, decorrerá **EXCLUSIVAMENTE** de pronunciamento judicial **EXPRESSO**, **não** podendo ser presumida.

Sentença **não** sujeita ao reexame necessário, em razão do que dispõe o art. 496, § 3º do Código de Processo Civil.

Transcorrido "in albis" o prazo recursal, **CERTIFIQUE-SE** o trânsito em julgado.

Se houver interposição de recurso de apelação, **INTIME(M)-SE** a(s) parte(s) recorrida(s) para que apresente(m) contrarrazões no prazo legal. Com a vinda das contrarrazões, **REMETAM-SE** os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, **independentemente de nova conclusão**.

De modo a evitar o oferecimento indevido de embargos de declaração, registre-se que ficam prejudicadas as demais alegações apresentadas pelas partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada neste julgamento, observando ainda que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

MENDES/RJ, *datado e assinado eletronicamente*.

FELIPE CONSONNI FRAGA
Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: FELIPE CONSONNI FRAGA
18/06/2025 13:44:43
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25061813444321900000184189746

IMPRIMIR GERAR PDF